

Répétitoire finalistes 2019: liaison

Troubles somatoformes, alimentaires, sexuels et de
l'identité de genre, du sommeil, abus de substances
non-addictives

12 juin

Dr M. Saraga

Parmi les propositions suivantes concernant l'abus de laxatifs, laquelle est **fausse**?

- A. Peut être le symptôme d'un trouble psychiatrique
- B. Peut être le symptôme d'un trouble du comportement alimentaire
 ne nécessite en principe pas une prise en charge médicale
- D. Peut être une complication de la prise de médicaments anticholinergiques
- E. Est rarement mentionné spontanément par les patients

L'abus de laxatifs peut être associé à un TCA mais aussi à des troubles à caractères obsessionnels, somatoformes ou délirants.

Il peut aussi survenir de manière isolée, avec l'installation d'une dépendance (constipation à l'arrêt).

Il nécessite souvent une prise en charge médicale, notamment en raison des complications du sevrage (mais aussi des co-morbidités psychiatriques fréquentes).

Les patients mentionnent rarement ce problème en consultation.

Un homme âgé de 53 ans, marié, consulte en se plaignant d'une « baisse de la libido ». A l'anamnèse, il apparaît qu'il a moins de désir sexuel et des troubles de l'érection. Il a récemment changé de poste de travail. Son épouse est décrite comme triste, repliée sur elle-même, depuis le départ de leur fille unique. Il présente un léger excès pondéral (BMI 29) et une légère hypertension (145/93). Quelle est la première mesure à prendre ?

- A. Une consultation urologique
- ☒ B. Une investigation psychopathologique
- C. Un entretien de couple
- D. Un entretien avec l'épouse
- E. La prescription de sildafénil

La baisse de libido peut avoir dans ce cas une composante organique, psycho-sociale ou les deux. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de rechercher un trouble anxieux ou dépressif qui pourrait contribuer, ou découler du problème.

Une consultation urologique peut être indiquée si les premières mesures proposées (après l'évaluation psychopathologique et une anamnèse et un status somatique plus fouillés) échouent, ou si l'investigation somatique révèle un signe inquiétant.

Un entretien de couple peut être envisagé, de même qu'un entretien avec l'épouse ou une prescription, mais c'est prématuré à ce stade.

Un homme de 24 ans, sans antécédents médicaux connus, est hospitalisé en urgence pour une dyspnée aiguë dont les investigations sont négatives. Il rapporte quelques épisodes similaires mais moins intenses ces derniers mois. Le diagnostic est une **attaque de panique**. Quelle attitude vous paraît la plus appropriée de la part du médecin des urgences ?

-  Expliquez le diagnostic de trouble panique et proposer de consulter un généraliste ou un psychiatre
- B. Rassurer le patient et proposer un rendez-vous de suivi chez un généraliste pour s'assurer que tout va bien
- C. Rassurer le patient et le renvoyer chez lui, en lui disant de revenir s'il se sent mal
- D. Faire une analyse urinaire à la recherche de cocaïne ou d'autres psychotropes
- E. Demander une consultation psychiatrique en urgence

Tout ne va pas bien pour ce monsieur présentant probablement un trouble panique, dont l'évolution peut être très défavorable sans prise en charge (même si ce n'est pas systématiquement le cas). Le rassurer est ainsi peu à propos. La cocaïne peut provoquer des attaques de panique, mais la recherche urinaire n'apporte rien sans une discussion préalable avec le patient.

Demander un avis psychiatrique en urgence est possible, mais pas nécessairement indispensable ni très utile dans l'urgence. L'essentiel est d'informer le patient sur le diagnostic et les possibilités de prise en charge.

Une femme de 67 ans, atteinte de carcinome mammaire métastatique, est hospitalisée en raison de vomissements et de troubles du comportement à domicile (désorientation, moments d'agitation, agressivité fluctuante), d'apparition récente. Après deux jours de réhydratation et d'un traitement antiémétique, l'évolution est favorable. La patiente réclame son retour à domicile mais le mari apparaît très angoissé de cette perspective. Quelle est l'attitude la plus appropriée?

- A. Expliquer au mari que la patiente est libre de ses décisions et qu'elle va donc quitter l'hôpital
- B. Expliquer à la patiente que son mari paraît angoissé et qu'il serait préférable qu'elle reste ou accepte un transfert en EMS.
- C. Solliciter l'unité d'éthique clinique
-  Demander un avis oncologique quant à l'opportunité d'une imagerie cérébrale à la recherche d'une lésion éventuellement traitable par radio- ou chimiothérapie
- E. Prescrire un antipsychotique atypique à faible dose

Le tableau présenté peut être lié à une **métastase cérébrale** de la maladie cancéreuse. On peut envisager ici une **intervention à visée palliative**, qui pourrait éventuellement **permettre un retour à domicile**. Cet aspect peut jouer un rôle essentiel dans les discussions à venir et devrait donc être abordé.

La prescription d'un antipsychotique pourrait se justifier une fois les origines de l'épisode d'agitation élucidées.

Quelle est la catégorie la plus à risque de suicide ?

- A. Femmes entre 15 et 35 ans
- B. Femmes divorcées
- C. Hommes jamais mariés
- D. Femmes avec activité professionnelle

Hommes de plus de 65 ans

Le risque est redoutable chez l'homme âgé de plus de 65 ans: isolement affectif, deuil, perte de statut social, perte du sentiment d'invulnérabilité.

Les propositions suivantes concernant l'insomnie sont exactes, sauf une. Laquelle ?

A. La prévalence de l'insomnie dans la population générale est de l'ordre de 10 à 15%.

B. L'insomnie occasionnelle est la plus fréquente.

 Le trouble est deux fois plus fréquent chez les hommes que chez les femmes après 40 ans.

D. Une comorbidité psychiatrique existe dans 1/3 des cas.

E. Fatigue, difficultés attentionnelles et perturbation de l'humeur font partie des symptômes fréquemment rapportés par les patients.

Concernant le trouble somatoforme douloureux, les propositions suivantes sont correctes **sauf**:

- A. L'objectif du traitement est l'amélioration du fonctionnement du patient avant la réduction des symptômes
-  B. il y a un fort risque de relation thérapeutique conflictuelle car les patients exagèrent volontairement leurs symptômes
- C. la répétition d'examens para-cliniques comporte un risque de chronicisation des douleurs
- D. une majorité de patients présentent aussi un autre diagnostic psychiatrique
- E. des études montrent une grande variabilité interindividuelle dans la réponse subjective à un stimulus douloureux

Tr. somatoforme douloureux

Les symptômes s'améliorent souvent après une amélioration fonctionnelle, plus rarement l'inverse.

La recherche obstinée de causes organiques peut favoriser le trouble (sentiment de ne pas être cru, notamment).

La co-morbidité avec les troubles dépressifs et anxieux (trouble panique notamment) est très fréquente, de même que les antécédents traumatiques, avec ou sans PTSD clinique.

La douleur est une expérience subjective et très variable.

Les patients n'exagèrent pas volontairement leurs symptômes : même si les symptômes peuvent être fluctuant selon le contexte, ils sont associés à un authentique sentiment de détresse des patients.

Parmi les propositions suivantes à propos des troubles dissociatif et factice, laquelle est vraie?

- A. Chez un patient présentant des crises convulsives, un diagnostic d'épilepsie documenté par EEG exclut un trouble dissociatif.
- B. Le trouble factice implique l'absence de pathologie associée.
- C. L'incidence d'abus physiques chez les patients souffrant de trouble dissociatif est supérieure à celui des patients souffrant d'un trouble affectif.
-  D. Il existe des signes cliniques neurologiques de non-organicité.
- E. Le trouble dissociatif représente une simulation de symptômes.

Le trouble dissociatif n'est pas une production volontaire de symptômes – il se différencie d'une simulation, tant sur le plan clinique que des corrélats neurobiologiques (p.ex. en neuroimagerie).

Les crises convulsives dissociatives sont fréquemment associées des crises épileptiques.

Le trouble factice est bien une production volontaire, simulée de symptômes, dans le but de pouvoir occuper une place de malade notamment dans le système familial; il est associé fréquemment à d'importantes difficultés psychiques, notamment un passé de maltraitance.

C'est entre autres sur la base des constatations neurologiques d'incompatibilité entre les plaintes et l'anatomie du système nerveux qu'est fait le diagnostic.

Parmi les propositions suivantes, laquelle est **fausse**?

- A. Un diagnostic de schizophrénie augmente le risque suicidaire par rapport à une population sans diagnostic psychiatrique
-  B. Les patients avec **troubles affectifs bipolaires** **se suicident moins** que les patients avec troubles unipolaires
- C. Une histoire familiale de suicide double le risque suicidaire
- D. Le facteur prédictif principal est une précédente tentative de suicide
- E. Le suicide est difficilement prédictible

Les patients bipolaires ont des taux de suicide deux à trois fois plus élevés que les patients unipolaires.

L'histoire familiale et les antécédents de tentatives de suicide sont des facteurs de risque majeur, mais le suicide reste difficilement prédictible.

Face à un tableau psychiatrique, les caractéristiques suivantes sont évocatrices d'une affection somatique sous-jacente **sauf** :

- A. une apparition soudaine des symptômes
 - B. la présence d'hallucinations visuelles
 - C. l'absence d'antécédents psychiatriques
 - D. la présence de troubles cognitifs sévères (mémoire, orientation)
-  la présence d'antécédents psychiatriques familiaux

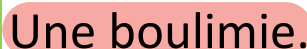
Quel est le traitement initial le plus approprié pour une patiente de 18 ans souffrant d'une anorexie mentale restrictive avec un indice de masse corporelle de 13 kg/m² :

- A. Une thérapie cognitivo-comportementale.
- B. Une psychothérapie analytique.
- C. Un traitement diététique.
- ☒ D. Une renutrition en milieu hospitalier.
- E. Une thérapie familiale.

13 kg/m² correspond à un état de dénutrition sévère qui expose la patiente à des complications somatiques potentiellement létales et qui nécessite la mise en œuvre d'une renutrition sous contrôle (risque de syndrome de renutrition inapproprié).

En outre, un tel état de dénutrition affecte nécessairement ses facultés cognitives limitant l'impact d'un travail psychothérapeutique.

Jeune femme de 20 ans présentant depuis 1 an et demi des crises de boulimie à raison de 5 épisodes par semaine compensées par des vomissements provoqués. Elle se dit obsédée et angoissée par son poids et sa silhouette, se sentant constamment grosse. Elle a déjà eu recours à de nombreux régimes. Son indice de masse corporelle est de 20 kg/m². En dehors des crises de boulimie, son alimentation est marquée par une nette restriction quantitative des apports et par l'éviction de nombreux aliments (pâtisseries, féculents, friture. ...). Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Une anorexie mentale avec crises de boulimie.
- B. Une anorexie mentale restrictive.
-   Une boulimie.
- D. Un trouble du comportement alimentaire atypique.
- E. Pas de diagnostic. Il s'agit d'un problème passager qui se résoudra spontanément.

Tous les éléments énoncés sont ceux participant au diagnostic de **boulimie**. Une anorexie mentale peut être exclue compte tenu de la normalité de l'indice de masse corporel.

Patient de 54 ans, sans antécédent psychiatrique, ayant bénéficié 72 heures plus tôt d'un pontage aorto-coronarien. Dans les suites opératoires, le patient présente de façon fluctuante des troubles de la vigilance, une agitation, une désorientation temporelle et des hallucinations visuelles. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ A. Un état confusionnel aigu.
- B. Une schizophrénie paranoïde.
- C. Un trouble panique.
- D. Un trouble de la personnalité de type anxieux.
- E. Une démence débutante.

} Peu probable car pas d'ATCD psy.

La nature des symptômes et le contexte post-opératoire sont typiques de l'ECA. L'absence d'antécédent psychiatrique rend très peu probables les autres diagnostics.

Patient de 58 ans connu pour une dépendance chronique à l'alcool, hospitalisé en raison d'une bronchopneumonie fébrile. Après mise en route d'une antibiothérapie, l'évolution est tout d'abord favorable. Au 4^{ème} jour, le patient présente un état d'agitation psycho-motrice, un tremor, des sudations profuses, une HTA et des hallucinations visuelles. Quel est le diagnostic le plus probable ?

A. Une schizophrénie paranoïde.

☒ B. Un delirium tremens.

C. Un état confusionnel aigu (ECA).

D. Un trouble panique

E. Un trouble de la personnalité de type anxieux.

← Possible mais OH chronique sous

Le diagnostic différentiel se pose avec un ECA. La notion de syndrome de dépendance à l'alcool principalement doit faire évoquer en 1^{er} lieu un delirium tremens.

Laquelle des informations suivantes concernant le transsexualisme est correcte ?

- A. Le transsexualisme est un phénomène récent et exclusif au monde occidental.
-  B. Le transsexualisme se définit par le désir permanent d'être débarrassé de ses caractères sexuels, d'acquérir et de mener la vie d'un sujet de l'autre sexe.
- C. La chirurgie de réassignation sexuelle n'améliore que rarement la qualité de vie des patients transsexuels.
- D. Le transsexualisme est un phénomène plus fréquemment rencontré chez les femmes que chez les hommes.
- E. On parle également de transsexualisme dans les cas où les sujets présentent une anomalie chromosomique.

Le **transsexualisme** se définit en effet par le **désir permanent d'appartenir au sexe opposé**.

Il s'agit d'un **diagnostic psychiatrique** et ce phénomène exclut tous les cas d'ambigüité sexuelle ou d'anomalie chromosomique, cas dans lesquels on parle d'hermaphrodisme.

Le transsexualisme a existé de tout temps mais est plus fréquent chez les **hommes**.

La **chirurgie** améliore sensiblement la **qualité de vie** des patients.

Concernant les paraphilies, laquelle de ces affirmations n'est pas correcte ?

- A. Les paraphilies sont des troubles sexuels caractérisés par la présence de pulsions ou pratiques qui sont déviantes et inhabituelles.
- B. Le fétichisme, l'exhibitionnisme et le voyeurisme sont typiquement des exemples de paraphilies.
-  C. L'acte paraphilique a rarement un caractère compulsif. *Non, a un caractère compulsif*
- D. Les comportements paraphiliques s'exacerbent souvent en cas de stress, d'anxiété ou de dépression.
- E. Les paraphilies sont plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes.

L'acte paraphilique a justement un caractère compulsif, à savoir que c'est un acte que le sujet accomplit malgré lui, même s'il le désapprouve, et que la non-exécution de cet acte génère de fortes angoisses (autres exemples d'actes compulsifs : achats, crises de boulimie).